

Transcrição do podcast de revisão do Módulo: Atuação dos Trabalhadores da Justiça e da Segurança Pública no Âmbito da PNAISP

Caio: Olha, pra gente começar nossa discussão, vamos pensar numa cena que acontece todo dia. Imagina assim: dentro de um presídio, um psiquiatra pede pro policial penal se retirar da sala. Pra quê? Pra garantir o sigilo da consulta, claro. Só que o policial recusa. Ele cita o protocolo de segurança. Resultado: a consulta é interrompida. Esse impasse, que a gente viu em alguns dos casos analisados, tá bem no centro do nosso debate de hoje. A complexa teia que envolve saúde, justiça e segurança no sistema prisional brasileiro.

Vivian: E esse exemplo é perfeito. Perfeito porque ele mostra a raiz do problema. Não é, assim, má vontade de nenhum dos lados. É um choque de culturas, de protocolos mesmo. Cada setor, sabe, saúde, segurança, justiça, cada um opera com suas próprias regras, suas prioridades. E o resultado muitas vezes é um sistema que acaba se sabotando. O grande desafio é fazer essas engrenagens rodarem juntas, algo que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, a PNAISP, tenta organizar.

Caio: Certo. Pra gente entender como se chega nesse tipo de impasse, talvez valha a pena dar um passo atrás e ver o papel de cada um. A justiça, por exemplo, parece algo tão distante do atendimento médico do dia a dia. Como que ela entra nessa equação?

Vivian: A justiça, ela atua como uma espécie de fiscalizadora externa. Juízes, promotores, defensores públicos, todos eles têm o poder de cobrar do Estado que o direito à saúde seja cumprido. Quer dizer, quando um tratamento é negado ou as condições são muito precárias, é a justiça que pode intervir. Ela pode determinar uma ação garantindo que a lei não seja só uma formalidade no papel. Funciona como um mecanismo de controle, sabe? Pra que as políticas públicas realmente aconteçam.

Caio: Entendi. Então a justiça é essa garantia. Mas e quem tá ali na linha de frente, no dia a dia? Eu penso muito no policial penal. A gente tende a associar o papel deles só com a vigilância, mas o que a gente analisou mostra um quadro bem mais complexo.

Vivian: Sim, e essa é uma mudança de perspectiva que é crucial. O policial penal é a ponte. Ele é a ponte entre a pessoa privada de liberdade e o serviço de saúde. Tinha um exemplo ótimo que era de um agente que percebe os primeiros sinais de um surto de gripe. E ele aciona imediatamente a equipe de atenção primária prisional. Essa atitude preventiva evitou um problema que seria muito, muito maior. O desafio é que essa proatividade ainda é mais exceção do que regra.

Caio: E isso nos leva de volta pros conflitos. O caso do sigilo médico me parece o mais difícil de resolver. Porque soa como um jogo de soma zero: ou o médico tem privacidade, ou o agente tem segurança. Existe uma saída pra isso? Como se constrói essa confiança pra que ninguém se sinta exposto?

Vivian: Olha, o que fica claro é que o problema não é a falta de regras, é o excesso de regras que não conversam entre si. A solução não tá em escolher um lado, mas em criar protocolos únicos, integrados. Isso pode significar desde adequar a arquitetura — por exemplo, ter salas de atendimento com visibilidade, mas sem escuta — até criar

avaliações de risco que sejam individualizadas. A confiança só vem com diálogo e principalmente com fluxos de trabalho que forcem todo mundo a usar a mesma linguagem.

Caio: Nossa, e aquela outra situação... da enfermeira que é barrada de entregar o medicamento controlado por causa de uma revista surpresa. É um exemplo perfeito de como duas ações, ambas corretas dentro de suas lógicas, podem gerar uma crise de saúde, tudo por pura falta de sincronia.

Vivian: Exatamente. E isso revela a falha central na gestão. Cada área tá otimizando a sua própria meta. A segurança quer garantir a ordem a qualquer custo, a saúde quer garantir o tratamento no horário certo. Sem uma comunicação constante, planejada, um procedimento acaba anulando o outro. A saúde de quem tá no sistema prisional não é responsabilidade só da equipe de saúde. É, é um desafio compartilhado por todos. Um ambiente seguro permite um tratamento melhor, e um tratamento eficaz ajuda a manter o ambiente seguro. Uma coisa depende da outra.

Caio: Então o que fica claro aqui é que saúde e segurança não podem ser tratadas como forças opostas. Elas são, na verdade, interdependentes. E essa colaboração planejada, a tal da intersetorialidade, é a única premissa que faz o sistema funcionar de verdade.

Vivian: É a única forma. A única forma de garantir o direito à saúde e ao mesmo tempo a dignidade de todos os envolvidos, incluindo os profissionais. O sucesso da PNAISP não depende de mais leis. Depende da capacidade de construir essas pontes no dia a dia, em cada procedimento, em cada decisão.

Caio: E isso nos deixa com uma reflexão final baseada em tudo que a gente conversou. Pensando na própria prática profissional de quem nos ouve: de que maneira é possível hoje começar a construir uma pequena ponte entre as áreas da saúde, da segurança e da justiça?

Vivian: É a única forma.